

094红霉素诱导的药物相互作用

Basi L J Denisel, et al

本文报道一例6岁儿童因患有阵发性强直癫痫大发作和病灶性小发作病史3年,服用抗惊厥药物酰胺咪嗪400mg,每日三次,共四个月。入院前5天患肺炎给予琥珀酸乙酯红霉素250mg,每日四次。入院前2天出现间歇性呕吐、乏力、头痛、头晕及行走困难,入院时呈昏睡状态,可唤醒、瞳孔大、凝视、眼球震颤、轻度腕运动障碍及躯干运动失调,血清酰胺咪嗪浓度由住院前7天的11.9mg/L上升至25.8mg/L(服药期间血药浓度为4~12mg/L),诊断为红霉素引起酰胺咪嗪蓄积中毒。停用红霉素并暂停服酰胺咪嗪24小时,血清酰胺咪嗪浓度下降到5.6mg/L,毒性反应消失。患者继续使用酰胺咪嗪治疗,剂量同前。随访观察,无毒性反应,血清浓度正常。

讨论 红霉素可使肝脏细胞色素P-450酶系统发生改变而影响药物代谢。Lazzezy等人指出,应用红霉素7天,NADPH—细胞色素还原酶活性和总细胞色素P-450浓度均增加。全部细胞色素P-450药物代谢产物化合形成酶—药物结合物。应用红霉素过程,其它药物排泄延缓可能与肝脏酶系统受抑制有关。

Carranco和Hroblervski等人报道:使用酰胺咪嗪的患者,即使服用最小剂量的红霉素,每日四次,在48~72小时之内也可出现中毒反应。Worg等人也证实健康自愿者应用红霉素过程中,同样发生酰胺咪嗪排泄下降的现象。

大量研究表明,红霉素与茶碱的相互作用有不同的结果,有的研究发现应用红霉素使茶碱排泄减少,但不是所有的研究都支持这一点。

Friedman报道一例使用地高辛的病例,当红霉素血中浓度恒定增加时,血清中地高辛浓度增加并出现中毒征兆,停用红霉素

之后,病人使用停用红霉素之前的地高辛剂量,不出现毒性反应,血清浓度和以前基础水平相同。这是由于地高辛是由肠道菌经过生物转化形成地高辛还原产物,经尿排泄。同时红霉素可影响肠道菌。

(《北美儿科临床》1987;26(3):117)

张淑华 韩景林摘译 李守邦 丁家华校)

095 诱导产生白细胞间素—2
的新化合物

Ramat Can, Israel

白细胞间素—2通常用来作为一种抗癌剂,但其在应用时偶尔可引起严重的甚至致死的副作用。据Ramat Gan研究人员报道:新近应用的这种白细胞间素—2诱导剂,则不出现这些副作用。据Bar—Han大学的一个研究小组报道:定期给小鼠注射三氯化胺(代号AS—101),能诱导白细胞产生的白细胞间素—2达到同样治疗效果,并同时能促进脾细胞产生较高水平的白细胞间素—2受体。此外,AS—101还能促进另一种增强免疫机能的细胞素——集落刺激因子的合成。研究还发现,定期使用10ug的AS—101能抑制小鼠纤维肉瘤组织生长,并能延长伴有转移性肺癌小鼠的生存期。

在给予大白鼠每周三次,每次剂量高达2mg/kg时,仍不出现中毒反应。该药对大白鼠的半数致死量为治疗量的500~1000倍。此外,在癌症、艾滋病和骨髓移植病人的第一阶段试用结果表明,在治疗剂量下,病人出现明显的中毒反应。

AS—101可能是通过增加淋巴细胞内钙离子浓度来促进白细胞间素—2的释放和白细胞间素—2受体的合成产生作用的。该研究小组认为,AS—101可以替代白细胞间素—2用于治疗,也可以直接加强白细胞间素—2的治疗作用。

(Medical World News 1988;44)

汪丽萍 张天旭摘译 张竞校)

(本栏责任编辑 牛铁兵)